

O Papel do Setor Privado e da Saúde Suplementar

Vamos começar entendendo uma questão fundamental que aparece com frequência nas provas de residência e que gera muita confusão entre os estudantes: a diferença entre **saúde complementar** e **saúde suplementar**. Esses dois conceitos parecem sinônimos, mas representam realidades jurídicas e operacionais completamente distintas dentro do nosso sistema de saúde.

Desde a Constituição Federal de 1988, o Brasil adota um modelo de sistema de saúde influenciado pelo **modelo beveridgeano**, caracterizado pela universalidade e pela participação da iniciativa privada. A Constituição estabelece que as instituições privadas poderão participar de forma **complementar** do Sistema Único de Saúde, sempre seguindo as diretrizes deste, mediante **contrato de direito público** ou **convênio**, tendo como preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Quando falamos de **saúde complementar**, estamos nos referindo àquelas situações em que o Estado, por meio desses contratos ou convênios, contrata serviços particulares para atender usuários do SUS. Um exemplo clássico é quando o SUS contrata clínicas privadas para realizar exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia, ou ainda clínicas de hemodiálise. O paciente atendido nesses serviços continua sendo usuário do SUS, recebendo atendimento gratuito e integral, mesmo que fisicamente esteja em uma instituição privada. O serviço privado, nesse caso, funciona como uma extensão do braço público e deve obedecer integralmente às diretrizes do SUS.

Por outro lado, quando falamos de **saúde suplementar**, estamos tratando das iniciativas privadas de planos de saúde, os chamados convênios ou seguros-saúde. Aqui está o ponto crucial para provas: a saúde suplementar não está obrigada a seguir as mesmas diretrizes do SUS. Ela possui regulamentação própria, embora

esteja subordinada à fiscalização e normatização de uma agência reguladora específica.

A Constituição também estabelece algumas vedações importantes em relação à iniciativa privada na saúde. Primeiramente, é **vedada a destinação de recursos públicos** para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Em segundo lugar, é **vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros** na assistência à saúde do país, salvo nos casos determinados por lei. Além disso, a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e derivados, sendo **vedado todo tipo de comercialização** desses elementos.

Passando agora para os dispositivos normativos da saúde suplementar, temos dois marcos legais fundamentais que você precisa memorizar para a prova. O primeiro é a **Lei 9.656 de 1998**, conhecida como a **Lei dos Planos de Saúde**, que regulamenta o funcionamento das operadoras e os direitos dos beneficiários. O segundo é a **Lei 9.961 de 2000**, que cria a **Agência Nacional de Saúde Suplementar**, a famosa ANS.

Vale um comentário crítico aqui: embora a ANS tenha sido formalmente criada apenas em 2000, sua existência já estava prevista na Lei dos Planos de Saúde de 1998, que estabelecia que os planos estariam subordinados às normas e à fiscalização desta agência. Ou seja, a ANS já vinha sendo gestada e organizada desde 1998, tendo sua criação oficial dois anos depois. Isso demonstra que houve um planejamento para estruturar a regulação do setor antes mesmo de a agência existir formalmente.

A Lei 9.656/98 estabelece que qualquer modalidade de produto, serviço ou contrato que apresente garantia de cobertura financeira de riscos à assistência à saúde, seja ela hospitalar ou odontológica, está sujeita a essa regulamentação. Portanto, não existe uma autonomia liberal completa para esse sistema. Lembre-se sempre: estamos falando de um **Sistema Único de Saúde**, e mesmo a saúde suplementar será normatizada através da ANS.

Outro dispositivo importante da Lei dos Planos de Saúde é o **ressarcimento ao SUS**. Funciona assim: quando um usuário que paga plano de saúde acaba utilizando um serviço do SUS, como uma tomografia ou uma internação, a operadora do plano estaria, em tese, obrigada a ressarcir o sistema público por esse atendimento. Na prática, esse ressarcimento frequentemente não é cobrado pelo SUS, o que representa uma das grandes críticas ao sistema. No entanto, o dispositivo legal existe e pode ser cobrado em prova.

A ANS, criada pela Lei 9.961/2000, é uma **autarquia sob regime especial**, vinculada ao Ministério da Saúde. Ela atua em todo o território nacional como órgão de **regulação, normatização, controle e fiscalização** das atividades que garantam a assistência suplementar. O objetivo institucional da ANS é a defesa do **interesse público**, o que é fundamental compreender: mesmo regulando serviços privados, a agência existe para proteger os usuários.

Aqui cabe uma explicação sobre o conceito de **autarquia**. Autarquias são serviços autônomos que possuem personalidade jurídica própria, distinta da administração direta. A ANS tem seu próprio patrimônio, sua própria receita e desenvolve atividades típicas que requerem certa descentralização e normatização específica. Ela não se confunde com o Ministério da Saúde nem com as secretarias estaduais ou municipais.

Agora vamos aos tipos de planos de saúde, tema que aparece com muita frequência em provas, especialmente no que diz respeito às regras de **rescisão unilateral**. Existem três categorias principais de planos.

Os **planos individuais ou familiares** são aqueles em que o indivíduo, pessoa física, ou sua família contrata diretamente o plano mediante adesão livre. A rescisão unilateral por parte da operadora nesses contratos só pode ocorrer em duas situações específicas: **fraude** por parte do contratante ou **inadimplência**. Fora dessas hipóteses, a operadora não pode rescindir o contrato unilateralmente. Esse é um ponto de prova clássico.

Já nos **planos coletivos por adesão**, a contratação é feita por um sindicato, associação ou outra entidade representativa. Para aderir, você precisa estar vinculado a essa organização. A rescisão unilateral, nesses casos, seguirá o que estiver **previsto no contrato** ou poderá ocorrer mediante a rescisão do contrato como um todo.

Os **planos coletivos empresariais** exigem vínculo empregatício: você precisa estar na empresa para ter direito ao plano. A rescisão também seguirá a previsão contratual ou poderá acontecer com a rescisão do contrato como um todo.

Perceba a diferença fundamental: nos planos individuais, a proteção do beneficiário é muito maior, pois a rescisão só pode ocorrer por fraude ou inadimplência. Nos planos coletivos, há mais flexibilidade para a operadora, desde que respeitadas as cláusulas contratuais.

Existe ainda uma proteção específica durante internações. É **proibido** que a operadora rescinda ou suspenda unilateralmente o contrato, independente do motivo, durante a internação do titular ou de dependente nos planos individuais ou familiares. Nos planos coletivos, embora a rescisão seja lícita, caso exista algum beneficiário ou dependente internado, a operadora deverá arcar com todos os gastos do atendimento hospitalar até a alta, desde que a internação tenha ocorrido durante a vigência do contrato. Da mesma forma, procedimentos solicitados e autorizados na vigência do contrato devem ser cobertos pela operadora, mesmo após a rescisão.

O Estatuto do Idoso contém proteções relacionadas à rescisão de contratos de planos de saúde para pessoas idosas. Porém, atenção: no Brasil, considera-se **idoso** a pessoa com idade igual ou superior a **60 anos**, e não 65 anos. Questões que mencionam 65 anos como limite para considerar alguém idoso estão incorretas segundo a legislação brasileira.

As **cooperativas médicas** que atuam na saúde suplementar, como a Unimed, não possuem autonomia especial. Todos os planos de saúde, independentemente de serem operados por cooperativas ou por outras modalidades de operadoras, estão

igualmente subordinados à fiscalização e regulamentação da ANS. Não existe regime diferenciado para cooperativas nesse aspecto.

Para finalizar, grave bem essa distinção essencial: **saúde complementar** segue as regras do SUS, pois é o SUS contratando serviços privados para atender seus usuários. **Saúde suplementar** é o serviço privado de planos de saúde, fiscalizado, normatizado e regulamentado pela ANS, uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, mas com personalidade jurídica própria.

